

WhatsApp-Chatverlauf (Export)

Teilnehmer: Doreen Kahl, Anne Kahl (Schwester)

[16.06.26, 19:22:10] Doreen Kahl: Bescheid ist da. GdB 40. Kein Ausweis. Sie schreiben, die Behandlung läuft ja noch.

[16.06.26, 19:25:44] Anne Kahl: Das ist doch verdreht. Erst sagen sie, es ist noch nicht fertig behandelt, und deshalb kriegst du weniger?

[16.06.26, 19:31:02] Doreen Kahl: So steht es da. Beim ersten Mal 2019 hatte ich sofort die 50, bis die fünf Jahre rum waren.

[16.06.26, 19:33:18] Anne Kahl: Eben. Und jetzt ist es ein Rezidiv, neue OP im April. Frag den Rentenberater, ob das nicht wieder fünf Jahre 50 sein müssen.

[20.06.26, 08:14:57] Doreen Kahl: Ich will nur nicht, dass die im Laden denken, ich komme nicht zurück. Der Ausweis fühlt sich wie ein Stempel an.

[20.06.26, 08:17:39] Anne Kahl: Der Ausweis ist Schutz, kein Urteil. Kündigungsschutz, Zusatzurlaub, später vielleicht Rente. Diagnose und Arbeitsfähigkeit sind zwei Paar Schuhe.

[26.06.26, 20:41:22] Anne Kahl: Ich fahre dich am 14.07. zur Chemo. Danach zwei drei Tage ausruhen, ich bring Essen.

[26.06.26, 20:43:05] Doreen Kahl: Danke. Die Treppe schaffe ich nach der Chemo kaum. Arm links wird immer dicker.

[03.07.26, 17:05:11] Doreen Kahl: Brenner sagt, die neue Heilungsbewährung läuft bis 2031 und der GdB müsste 50 sein. Widerspruch ist raus.

[03.07.26, 17:06:48] Anne Kahl: Gut. Dann kämpfen wir. Du machst das richtig.

Von	anne.kahl@privatpost.de
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Fri, 26 Jun 2026 11:18:00 +0200
Betreff	Doreen will nicht als schwerbehindert abgestempelt werden

Guten Tag Herr Brenner,

meine Schwester Doreen schwankt weiterhin zwischen dem Wunsch nach Schutz und der Sorge, im Betrieb nur noch als krank angesehen zu werden. Bitte erläutern Sie ihr im Termin am 2. Juli, dass der Grad der Behinderung nicht automatisch eine Aussage über die tägliche Arbeitsfähigkeit enthält. Sie möchte nach der Behandlung in die Buchhandlung zurückkehren, kann derzeit aber weder längere Zeit stehen noch Bücherkisten tragen.

Ich begleite sie zu den Infusionen. Nach den Terminen am 12. Mai, 2. Juni und 23. Juni brauchte sie jeweils zwei bis drei Tage Hilfe beim Einkaufen und bei der Körperpflege. Die Treppe zu ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss schaffte sie nur mit Pausen. Seit der Operation am 4. April ist der linke Arm am Nachmittag sichtbar geschwollen; die Kompressionsversorgung wurde am 18. Juni angepasst. Frau Dr. Voigt hat außerdem eine ausgeprägte Fatigue dokumentiert.

Im Bescheid vom 16. Juni wird zwar das Rezidiv erwähnt, die laufende Chemotherapie aber nur knapp abgehandelt. Ich habe die Entlassungsunterlagen, den Therapieplan und meine Fahrtenliste eingescannt. Bitte sagen Sie Bescheid, wenn Sie auch eine eigene Schilderung zu den Tagen nach der Infusion benötigen. Doreen möchte keine Übertreibung, aber die tatsächlichen Einschränkungen sollen vollständig erfasst sein.

Viele Grüße

Anne Kahl

Am Vögenteich 17, 18055 Rostock

Telefon 0381 458 30 97

Datei: 17_email_arbeitgeber_fehlzeiten_anpassung.eml

Von	Personalbüro Hafenbuch Verlag <personal@hafenbuch.de>
An	Eva Kießling <eva.kiessling@posteo.de>
Datum	Wed, 08 Jul 2026 13:26:00 +0200
Betreff	Arbeitsplatz und Fehlzeiten während der Behandlung

Sehr geehrte Frau Kießling, wir haben die Fehlzeiten seit April anhand der Bescheinigungen erfasst. An den Therapiewochen waren Sie jeweils fünf bis acht Arbeitstage abwesend. An den übrigen Tagen arbeiteten Sie bislang überwiegend von zu Hause und kamen zu zwei Redaktionssitzungen ins Büro.

Der höhenverstellbare Tisch und die Spracherkennungssoftware sind seit 1. Juli eingerichtet. Das Archivheben übernimmt vorläufig Herr Rüß. Für den Terminplan August benötigen wir nur die voraussichtlichen Behandlungstage, keine Diagnosen oder Befundberichte.

Bitte teilen Sie Frau Mäßler bis 20. Juli mit, ob Sie weiterhin an den Dienstagssitzungen teilnehmen können. Die derzeitige Aufgabenverteilung ist bis Ende August befristet und wird danach gemeinsam besprochen.

Freundliche Grüße
Personalbüro Hafenbuch Verlag
personal@hafenbuch.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Klinikum Südstadt Rostock - Brustzentrum

Betreff: Befundbericht zu Frau Eva Kießling nach Brustkrebsrezidiv

Unser Zeichen: BRZ 26/1188 Kießling

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

Datei: eml/01_landesamt_eingangsbestaetigung.eml

Von	LAGuS MV - Widerspruchsstelle <widerspruch@lagus-mv.de>
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Wed, 01 Jul 2026 10:22:00 +0200
Betreff	Eingang Widerspruch GdB - Doreen Kahl, Az. SB 2026-40-2217

Sehr geehrter Herr Brenner,

wir bestätigen den Eingang Ihres Widerspruchs gegen den Bescheid vom 16.06.2026 (Gesamt-GdB 40, keine Schwerbehinderteneigenschaft) in der Sache Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976.

Der Vorgang wird der versorgungsärztlichen Stelle zur erneuten Bewertung vorgelegt. Wir bitten um Vorlage der vollständigen onkologischen Unterlagen zum Rezidiv, insbesondere zum Operationsdatum und zum Beginn der Systemtherapie, damit die Frage der erneuten Heilungsbewährung geprüft werden kann.

Bis zum Abschluss der Prüfung können Sie weitere Befunde nachreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

H. Radloff

Landesamt für Gesundheit und Soziales MV, Widerspruchsstelle

Datei: eml/02_tumorzentrum_befunduebersendung.eml

Von	Onkologisches Zentrum Rostock <ambulanz@onkozentrumsrostock.de>
An	rentenberater@privatpost.de
Datum	Thu, 25 Jun 2026 12:36:00 +0200
Betreff	Befundübersendung Doreen Kahl - Rezidiv und Heilungsbewährung

Sehr geehrter Herr Brenner,

auf Ihre Anforderung übersende ich unseren Bericht vom 10.06.2026 sowie eine ergänzende Stellungnahme (gesonderte Anlage) zu Frau Doreen Kahl.

Kurz zusammengefasst: Es liegt ein lokal-regionales Rezidiv des Mammakarzinoms links mit Befall axillärer Lymphknoten vor. Die operative Entfernung erfolgte am 04.04.2026, die adjuvante Chemotherapie läuft seit dem 12.05.2026, Bestrahlung und endokrine Therapie sind angeschlossen. Mit der erneuten operativen Geschwulstentfernung beginnt sozialmedizinisch eine neue Heilungsbewährung.

An Funktionsfolgen bestehen ein Lymphödem des linken Armes Grad zwei mit Bewegungseinschränkung der Schulter, eine ausgeprägte Fatigue sowie eine beginnende Polyneuropathie der Finger. Ich bitte, diese Folgen und die erneute Erkrankung eigenständig zu würdigen und nicht die laufende Therapie pauschal gegen die Feststellung zu verwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Sabine Voigt

Onkologisches Zentrum Rostock

Datei: eml/03_bevollmaechtigter_heilungsbewaehrung.eml

Von	Uwe Brenner - Rentenberatung <rentenberater@privatpost.de>
An	LAGuS MV - Widerspruchsstelle <widerspruch@lagus-mv.de>
Kopie	doreen.kahl@privatpost.de
Datum	Fri, 03 Jul 2026 15:18:00 +0200
Betreff	WG: Widerspruch GdB Doreen Kahl - erneute Heilungsbewährung, Az. SB 2026-40-2217

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Radloff,

anbei die angeforderten onkologischen Unterlagen. Die maßgeblichen Daten sind belegt: erneute operative Geschwulstentfernung am 04.04.2026, Beginn der adjuvanten Chemotherapie am 12.05.2026.

Damit ist durch das Rezidiv eine neue Heilungsbewährung ausgelöst worden, die fünf Jahre ab der Geschwulstentfernung, also bis zum 04.04.2031, läuft. Während dieser Heilungsbewährung ist der Teilverlust der Brust nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zu bewerten. Das Lymphödem des linken Armes Grad zwei tritt eigenständig hinzu.

Der angefochtene Bescheid bleibt mit einem Gesamt-GdB von 40 hinter diesem Heilungsbewährungssatz zurück und verwendet die laufende Therapie zugleich als Anerkennungsgrund und als Begrenzung. Ich beantrage die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ab Antragstellung sowie Akteneinsicht.

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Brenner
Rentenberater (Rechtsdienstleistungsregister)

Datei: 04_therapiekalender.csv

datum	termin	folge	arbeitsausfall
2026-04-04	Operation axilläre Lymphknoten	Drainage und Schmerz	14 Tage
2026-05-12	Chemotherapie Zyklus 1	Übelkeit und Fatigue	7 Tage
2026-06-02	Chemotherapie Zyklus 2	Polyneuropathie Finger	9 Tage
2026-06-23	Chemotherapie Zyklus 3	Lymphödem verstärkt	offen
2026-07-14	Chemotherapie Zyklus 4 geplant	Transport durch Schwester	offen

Datei: 09_gdb_heilungsbewaehrung_zeitleiste.csv

phase

Erstdiagnose

datum_beginn

2019-04-08

ereignis

Mammakarzinom links Erstdiagnose

grundlage

Diagnosestellung

phase

Ersttherapie

datum_beginn

2019-05-20

datum_ende

2019-11-30

ereignis

Brustoperation Chemotherapie Bestrahlung

gdb_maßgeblich

50

grundlage

Heilungsbewährungssatz nach Geschwulstentfernung

phase

Heilungsbewährung eins

datum_beginn

2019-05-20

datum_ende

2024-05-20

ereignis

fünf Jahre ohne Rezidiv

gdb_maßgeblich

50

grundlage

Heilungsbewährung fünf Jahre ab Geschwulstentfernung

phase

Herabsetzung

datum_beginn

2024-07-15

ereignis

Ablauf Heilungsbewährung ohne Rezidiv

gdb_maßgeblich

30

grundlage

Restfunktion nach abgelaufener Heilungsbewährung

phase

Rezidiv

datum_beginn

2026-02-16

ereignis

lokal-regionales Rezidiv axilläre Lymphknoten

gdb_maßgeblich

Neubeginn

grundlage

erneute Heilungsbewährung wird ausgelöst

phase

Rezidivtherapie

datum_beginn

2026-04-04

datum_ende

laufend

ereignis

Operation Chemotherapie ab 2026-05-12 Bestrahlung geplant

gdb_maßgeblich

50

grundlage

neuer Heilungsbewährungssatz nach Geschwulstentfernung

phase

Heilungsbewährung zwei

datum_beginn

2026-04-04

datum_ende

2031-04-04

ereignis

laufende Heilungsbewährung nach Rezidiv

gdb_maßgeblich

50

grundlage

fünf Jahre ab Geschwulstentfernung 2026-04-04

phase

Bescheid

datum_beginn

2026-06-16

ereignis

festgestellter Gesamt-GdB streitig

gdb_maßgeblich

40

grundlage

Brustkrebs 40 Lymphödem 20 psychisch 10 integrativ 40

phase

Nachprüfung frühestens

datum_beginn

2031-04-04

ereignis

Ende Heilungsbewährung zwei

gdb_maßgeblich

offen

grundlage

frühester Zeitpunkt einer Nachprüfung

Datei: 18_therapie_lymphoedem_und_belastung.csv

■Datum	Therapie	Armumfang_D ifferenz_cm	Gehtest_Mete r	Fehltage	Hilfsmittel	Quelle
2026-04-14	Operation	1.2		12		Operationsber icht
2026-05-18	Zyklus 1	1.8	421	6	Kompressions ärmel	Ambulanzbog en
2026-06-08	Zyklus 2	2.4	398	5	Kompressions ärmel	Ambulanzbog en
2026-06-29	Zyklus 3	3.1	362	8	Lymphdrainag e	Ambulanzbog en
2026-07-06	Kontrolle	3.1		2	Spracherkenn ung Arbeitsplatz	Arzt und Personalmail

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_onkologie.docx

Mandatsnotiz Onkologie und GdB

1. Mandantin

Mandantin ist Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976, Verkäuferin in einer Buchhandlung in Rostock. Brustkrebs links 2019, Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. GdB 50 wurde damals befristet festgestellt und 2024 nach Ablauf der Heilungsbewährung auf 30 herabgesetzt. Seit Februar 2026 Rezidiv in axillären Lymphknoten, erneute Therapie.

2. Verfahren

Änderungsantrag 18.03.2026. Bescheid 16.06.2026: Gesamt-GdB 40, keine Schwerbehinderteneigenschaft. Begründung: Therapie laufe, Funktionsfolgen noch nicht dauerhaft beurteilbar. Zugang 19.06.2026, Widerspruchsfrist bis 19.07.2026.

3. Auftrag

Widerspruch, vollständige Befundsammlung, Prüfung vorläufiger Nachteilsausgleiche und Abstimmung mit Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld, Reha und möglicher Erwerbsminderung. Das Ergebnis offen halten: Es geht um Funktionsfolgen, Rezidivlage und Zeitraum, nicht um eine automatische Dauerfeststellung.

Datei

Office-Dokument: 02_onkologiebericht.docx

Onkologiebericht

1. Diagnose und Verlauf

Onkologisches Zentrum Rostock, Bericht 10.06.2026. Lokal-regionales Rezidiv Mammakarzinom links, axilläre Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv, HER2 negativ. Therapie: Operation 04.04.2026, adjuvante Chemotherapie ab 12.05.2026, anschließend Bestrahlung und endokrine Therapie geplant.

2. Funktionsfolgen

Lymphödem linker Arm Grad 2, Bewegungseinschränkung Schulter links, ausgeprägte Fatigue, Polyneuropathie an Fingern nach erster Chemogabe, Übelkeit, Schlafstörungen. Ärztliche Empfehlung: keine stehende Vollzeittätigkeit, keine Lasten über 5 kg links, Reha nach Abschluss der Bestrahlung.

3. Prognose

Therapie kurativ intendiert, Rückfallrisiko erhöht. Die Ärztin bittet um Berücksichtigung der erneuten Erkrankung und der gegenwärtigen Therapiebelastung.

Histologie, Therapie und Funktionsfolgen

Der pathologische Bericht nach der Operation vom 4. April 2026 beschreibt ein lokal-regionales Rezidiv des Mammakarzinoms links mit Beteiligung axillärer Lymphknoten. Das Tumorboard vom 15. April empfahl eine adjuvante Chemotherapie, anschließende Bestrahlung und endokrine Therapie. Die Infusionen begannen am 12. Mai im Drei-Wochen-Rhythmus.

Dokumentiert sind Fatigue, Übelkeit, sensible Beschwerden an Händen und Füßen sowie ein linksseitiges Lymphödem. Doreen kann nach den Infusionen zwei bis drei Tage kaum Treppen steigen und benötigt Hilfe beim Einkauf. Die Schulterbeweglichkeit links ist vermindert; eine Kompressionsversorgung und Physiotherapie wurden verordnet. Prognoseaussagen bleiben dem weiteren Verlauf vorbehalten.

Datei

Office-Dokument: 03_bescheid_gdb_40.docx

Bescheid GdB 40

1. Entscheidung

Das Landesamt stellt einen Gesamt-GdB von 40 ab 18.03.2026 fest. Eine Schwerbehinderteneigenschaft wird nicht anerkannt.

2. Begründung

Die Behörde bewertet Brustkrebserkrankung nach Rezidiv und Therapiebelastung mit Einzel-GdB 40, Lymphödem mit 20 und psychische Belastung mit 10. Eine höhere Bewertung sei wegen noch nicht abgeschlossener Behandlung nicht möglich.

3. Auffälligkeit

Die Behörde verwendet die laufende Therapie zugleich als Anerkennungsgrund und als Begrenzung. Der Onkologiebericht zur Rezidivsituation und die konkreten Einschränkungen im Armgebrauch werden nicht erkennbar vertieft.

Verfügung, Bewertungsansatz und Zugang

Das Landesamt stellt mit Bescheid vom 16. Juni 2026 ab Antragseingang einen Grad der Behinderung von 40 fest. Genannt werden die Tumorerkrankung nach Rezidiv, ein Lymphödem des linken Arms und psychovegetative Begleiterscheinungen. Ein Merkzeichen wird nicht zuerkannt. Die Behörde kündigt eine Nachprüfung nach Abschluss der laufenden Behandlung an.

Als ausgewertete Unterlagen erscheinen Operationsbericht, Tumorboardbeschluss und hausärztlicher Befund. Die Stellungnahme des Tumorzentrums vom 10. Juni ist im Anlagenverzeichnis nicht aufgeführt. Doreen fand den Bescheid am 19. Juni im Briefkasten; Umschlag und erste Seite wurden am selben Tag fotografiert. Die Monatsfrist ist vorsorglich ab diesem Zugang notiert.

Datei

Office-Dokument: 05_arbeitgebernotiz_buchhandlung.docx

Arbeitgebernotiz Buchhandlung

1. Tätigkeit

Doreen Kahl arbeitet normalerweise 30 Wochenstunden im Verkauf, Wareneingang und Veranstaltungsservice. Sie trägt Bücherkisten, räumt Regale, steht an der Kasse und betreut Lesungen.

2. Einschränkungen

Seit Mai 2026 sind Kistenheben, längeres Stehen und Abendveranstaltungen kaum möglich. Kolleginnen übernehmen Wareneingang. Die Arbeitgeberin bietet reduzierte Stunden, kann aber keine reine Sitzkasse garantieren.

3. Bedeutung

Die Notiz zeigt konkrete Teilhabefolgen. Für den GdB ist nicht der Arbeitsplatz allein maßgeblich, aber die Funktionsfolgen werden dadurch greifbar: Armgebrauch, Fatigue, Belastbarkeit, Infektionsschutz und Wege zu Therapie.

Tätigkeitsprofil und Wiedereingliederung

Doreen arbeitet seit 2008 in der Buchhandlung Am Kröpeliner Tor mit 32 Wochenstunden. Zu ihren Aufgaben gehören Kundenberatung, Kasse, Warenannahme, Einsortieren und die Vorbereitung kleiner Veranstaltungen. Bücherkisten wiegen regelmäßig acht bis zwölf Kilogramm; das obere Lager ist nur über eine Treppe erreichbar.

Seit dem 11. April ist Doreen arbeitsunfähig. Filialleiterin Antje Möller kann einen vorübergehenden Einsatz an Kasse und Beratung ohne Warenannahme organisieren, sobald die behandelnden Ärzte eine stufenweise Rückkehr befürworten. Ein Termin oder konkreter Stundenplan besteht noch nicht. Die Arbeitgeberin hat keine Einsicht in den GdB-Antrag und verlangt keine Diagnosemitteilung.

Datei

Office-Dokument: 06_widerspruch_entwurf.docx

Widerspruchsentwurf GdB Krebsrezidiv

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 16.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft ab Antragstellung, hilfsweise erneute Entscheidung nach Beiziehung der vollständigen onkologischen Unterlagen.

2. Begründung

Die Behörde hat Rezidiv, laufende Systemtherapie, Lymphödem, Fatigue und konkrete Funktionsfolgen nicht hinreichend zusammengeführt. Gerade die erneute Erkrankung nach früherer Heilungsbewährung verlangt eine eigenständige Bewertung. Die laufende Therapie darf nicht pauschal gegen die Feststellung verwendet werden, wenn die Teilhabebeeinträchtigung bereits aktuell erheblich ist.

3. Beweismittel

Onkologiebericht, Therapiekalender, Lymphödemtherapie, Arbeitgebernotiz, Fotos Kompressionsversorgung, Befund Psychoonkologie und Reha-Antrag.

Belegführung und noch offene Unterlagen

Der Widerspruch nimmt auf das Operationsdatum, den Beginn der Chemotherapie und den Bericht des Tumorzentrums Bezug. Beigefügt werden Histologie, Tumorboardbeschluss, Therapieplan, Lymphödemmessung und eine kurze Arbeitsplatzbeschreibung. Die Schwester schildert nur selbst beobachtete Hilfen nach den Infusionen.

Zugleich wird Akteneinsicht in die versorgungsärztliche Stellungnahme verlangt, weil der jüngste Tumorbericht im Bescheid nicht erkennbar ausgewertet ist. Eine abschließende Prognose oder Rentenaussage wird nicht vorweggenommen. Der Entwurf bleibt bis zur ärztlichen Freigabe der Anlagen und zur Kontrolle des Zugangsdatums unversandt.

Datei

Office-Dokument: 07_renten_reha_krankengeld.docx

Reha, Krankengeld und Rentenbezug

1. Gegenwärtige Leistungen

Die Mandantin bezieht Entgeltfortzahlung, danach voraussichtlich Krankengeld. Onkologische Reha ist nach Bestrahlung geplant. Versicherungsverlauf zeigt 31 Jahre Pflichtbeiträge, Kinderberücksichtigungszeiten und Teilzeitphasen.

2. Rentenberaterliche Prüfung

Kurzfristig steht GdB-Widerspruch und Reha im Vordergrund. Mittelfristig: Nahtlosigkeitsrisiko, Erwerbsminderungsrente nur bei fortbestehender Leistungsminderung, Altersrente schwerbehinderter Menschen wegen Alter noch fern. Die Dokumente sollten dennoch so sortiert werden, dass später keine Therapielücken und Funktionsfolgen verloren gehen.

Leistungs- und Fristenstand

Die Entgeltfortzahlung endete nach Arbeitgeberberechnung am 22. Mai 2026. Seit 23. Mai zahlt die Krankenkasse Krankengeld; der erste Bescheid und die Berechnung liegen vor. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen schließen bislang ohne Lücke aneinander an. Der nächste ärztliche Termin ist am 14. Juli.

Das Tumorzentrum empfiehlt eine onkologische Rehabilitation nach Abschluss der Bestrahlung. Ein Antrag ist noch nicht gestellt. Eine Rentenprüfung wird nur als mögliche spätere Folge vorgemerkt, falls die Leistungsfähigkeit längerfristig eingeschränkt bleibt. Krankengeld, Reha, GdB und Rente erhalten getrennte Anträge, Belege und Fristen.

Datei

Office-Dokument: 10_versorgungsaerztliche_stellungnahme.docx

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern

Versorgungsärztliche Stelle

Aktenzeichen: SB 2026-40-2217

Versorgungsärztliche gutachterliche Stellungnahme nach Aktenlage

Datum: 10.06.2026

Betroffene: Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976

1. Auftrag

1.1 Zu bewerten ist der Änderungsantrag vom 18.03.2026. Bisher festgestellt war ein Grad der Behinderung von 30 nach abgelaufener Heilungsbewährung.

1.2 Grundlage sind der Kurzbefund des behandelnden Onkologischen Zentrums sowie die Angaben der Antragstellerin. Eine persönliche Untersuchung ist nicht erfolgt.

2. Funktionsbeeinträchtigungen und Einzelbewertung

2.1 Für die Brustkrebserkrankung nach Rezidiv und die gegenwärtige Therapiebelastung wird ein Einzel-Grad der Behinderung von 40 angesetzt.

2.2 Das Lymphödem des linken Armes wird mit einem Einzel-Grad der Behinderung von 20 bewertet, die psychische Belastung mit 10.

3. Bildung des Gesamt-Grades der Behinderung

3.1 Aus dem führenden Wert 40 und den hinzutretenden Beeinträchtigungen wird integrativ ein Gesamt-Grad der Behinderung von 40 gebildet.

3.2 Eine höhere Bewertung ist nach hiesiger Auffassung derzeit nicht möglich, weil die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist und die dauerhaften Funktionsfolgen noch nicht sicher beurteilt werden können.

4. Anmerkung

4.1 Diese Stellungnahme bewertet die Erkrankung als noch nicht abgeschlossen behandelt. Die Frage, ob durch das Rezidiv mit erneuter operativer Geschwulstentfernung am 04.04.2026 eine neue Heilungsbewährung mit einem eigenständigen Bewertungssatz ausgelöst worden ist, wurde hier nicht abschließend geprüft und sollte im Widerspruchsverfahren nachgeholt werden.

gez. Dr. med. R. Petermann

Versorgungsärztliche Stelle, LAGuS Mecklenburg-Vorpommern

Datei

Office-Dokument: 11_tumorzentrum_stellungnahme_heilungsbewaehrung.docx

Onkologisches Zentrum Rostock

Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie

Südring 81, 18059 Rostock

Ergänzende sozialmedizinische Stellungnahme zur Heilungsbewährung

Datum: 24.06.2026

Patientin: Doreen Kahl, geboren am 30.05.1976

1. Anlass

1.1 Diese Stellungnahme ergänzt unseren Bericht vom 10.06.2026 und dient der Vorlage im Widerspruchsverfahren gegen den Feststellungsbescheid vom 16.06.2026.

2. Diagnose und Behandlungsverlauf

2.1 Es liegt ein lokal-regionales Rezidiv eines Mammakarzinoms links mit Befall axillärer Lymphknoten vor, hormonrezeptorpositiv, HER2-negativ.

2.2 Die operative Entfernung des Rezidivs erfolgte am 04.04.2026. Seit dem 12.05.2026 läuft eine adjuvante Chemotherapie; Bestrahlung und endokrine Therapie sind angeschlossen.

2.3 Die Ersterkrankung war 2019 operativ, chemotherapeutisch und strahlentherapeutisch behandelt worden; die damalige Heilungsbewährung war ohne Rezidiv abgelaufen, weshalb der Grad der Behinderung 2024 auf 30 herabgesetzt worden war.

3. Sozialmedizinische Einordnung der Heilungsbewährung

3.1 Mit der erneuten operativen Geschwulstentfernung am 04.04.2026 beginnt sozialmedizinisch eine neue Heilungsbewährung. Diese läuft regelhaft fünf Jahre, im vorliegenden Fall damit bis zum 04.04.2031.

3.2 Während dieser Heilungsbewährung ist die Erkrankung nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 zu bewerten. Eine Herabstufung während der laufenden Heilungsbewährung wäre nicht sachgerecht.

4. Funktionsfolgen unabhängig von der Heilungsbewährung

4.1 Es besteht ein Lymphödem des linken Armes Grad zwei mit schmerzhafter Bewegungseinschränkung der Schulter und einer Belastungsgrenze von etwa fünf Kilogramm.

4.2 Hinzu treten eine ausgeprägte tumor- und therapiebedingte Fatigue, eine beginnende Polyneuropathie der Finger sowie Schlafstörungen. Eine stehende Vollzeittätigkeit ist derzeit nicht leidensgerecht.

5. Ergebnis

5.1 Aus onkologischer Sicht ist die erneute Erkrankung eigenständig zu bewerten. Der Heilungsbewährungssatz von mindestens 50 begründet die Schwerbehinderteneigenschaft; die laufende Therapie spricht nicht gegen, sondern für eine erhebliche gegenwärtige Teilhabebeeinträchtigung.

gez. Dr. med. Sabine Voigt

Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie

Datei

Office-Dokument: 16_onkologischer_verlaufsbericht_rezidiv.docx

KLINIKUM SÜDSTADT ROSTOCK

Brustzentrum | Klinik für Frauenheilkunde und Onkologie

Südring 81 | 18059 Rostock | Telefon 0381 4401-0 | brustzentrum@klinikum-rostock.de

Landesamt für Gesundheit und Soziales
Versorgungsamt
Erich-Schlesinger-Straße 35
18059 Rostock

Rostock, 7. Juli 2026

Befundbericht zu Frau Eva Kießling nach lokoregionärem Brustkrebsrezidiv

Ihr Zeichen: LAGuS-SB 44/26381 | Unser Zeichen: BRZ 26/1188 | Behandlungsfall: 30077419

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Ihre Anfrage vom 23. Juni 2026 berichten wir über den aktuellen onkologischen Verlauf und die hier dokumentierten funktionellen Auswirkungen. Die Angaben beruhen auf den ambulanten Untersuchungen, dem Operationsbericht, dem Therapiekalender und den physiotherapeutischen Verlaufsbögen.

1. Patientin und Diagnosen

Patientin	Eva Kießling, geboren am 13. November 1969, Krämerstraße 22, 18055 Rostock
Erstdiagnose	Mammakarzinom links, 2019; brusterhaltende Operation, adjuvante Bestrahlung und endokrine Therapie
Aktueller Befund	Lokoregionäres Rezidiv links, histologisch gesichert am 18. März 2026
Operation	Resektion des Rezidivs und axilläre Lymphknotenrevision am 14. April 2026
Begleiterkrankungen	Arterielle Hypertonie, medikamentös eingestellt; degenerative Veränderungen der Halswirbelsäule

2. Behandlung seit dem Rezidiv

Nach der Operation begann am 18. Mai 2026 eine systemische Therapie im dreiwöchigen Abstand. Der dritte Zyklus wurde am 29. Juni 2026 verabreicht. In den ersten vier bis fünf Tagen nach jedem Zyklus bestehen ausgeprägte Übelkeit, Appetitminderung und ein Ruhebedarf von mehreren Stunden täglich. Eine stationäre Aufnahme war bislang nicht erforderlich.

Seit dem 9. Mai 2026 wird wegen einer zunehmenden Schwellung des linken Arms eine komplexe physikalische Entstauungstherapie durchgeführt. Frau Kießling trägt tagsüber einen maßgefertigten Kompressionsärmel und erhält derzeit zweimal wöchentlich manuelle Lymphdrainage. Hautläsionen oder eine akute Infektion liegen nicht vor.

3. Objektive Befunde am 7. Juli 2026

Armumfang	Unterarm links 28,7 Zentimeter, rechts 25,6 Zentimeter; Differenz 3,1 Zentimeter
Schulterbeweglichkeit	Aktive Abduktion links 105 Grad, rechts 165 Grad; Elevation links 118 Grad

Kraft	Handkraft links 18 Kilogramm, rechts 27 Kilogramm; schmerzbedingtes Nachlassen bei Wiederholung
Belastungstest	Sechs-Minuten-Gehtest 362 Meter; anschließend zehn Minuten Sitzpause wegen Erschöpfung
Allgemeinzustand	ECOG 1 bis 2 im Therapieintervall; Gewicht 68,4 Kilogramm bei 169 Zentimetern Körpergröße
Labor	Leukozyten 3,2 G/l, Hämoglobin 10,8 g/dl, Thrombozyten 184 G/l am 6. Juli 2026

4. Auswirkungen im Alltag

Frau Kießling kann den linken Arm nur kurz über Schulterhöhe einsetzen. Das Aufhängen von Wäsche, längeres Tragen von Einkaufstaschen und Arbeiten mit gestrecktem Arm führen nach wenigen Minuten zu Spannungsgefühl und Schmerz. Feinmotorische Verrichtungen sind möglich, dauern bei Schwellung jedoch länger. Für schwere Einkäufe und die Reinigung höherer Flächen benötigt sie Unterstützung durch ihre Schwester.

An den ersten vier bis fünf Tagen nach einer Infusion verlässt Frau Kießling die Wohnung nur zu notwendigen Terminen. An den übrigen Tagen kann sie kurze Wege selbstständig zurücklegen. Eine Gehstütze wird nicht benötigt. Nach einer Strecke von etwa 500 Metern oder nach Treppen über zwei Etagen ist regelmäßig eine Pause erforderlich.

5. Weiterer Verlauf

Die nächsten Therapiezyklen sind für den 20. Juli und 10. August 2026 vorgesehen. Eine bildgebende Verlaufskontrolle ist für den 24. August 2026 terminiert. Erst danach lässt sich beurteilen, ob das bisherige Schema fortgeführt wird. Die Dauer des Lymphödems und das Ausmaß einer bleibenden Bewegungseinschränkung können derzeit nicht zuverlässig prognostiziert werden.

Der Bericht beschreibt den gegenwärtigen medizinischen und funktionellen Zustand. Eine rechtliche Bewertung oder Festlegung eines Grades der Behinderung wird nicht vorgenommen.

6. Beigefügte Unterlagen

- Operationsbericht vom 14. April 2026
- Therapiekalender vom 18. Mai bis 10. August 2026
- Physiotherapeutische Umfangsmessungen vom 9. Mai bis 7. Juli 2026
- Laborblatt vom 6. Juli 2026
- CSV-Export Therapieverlauf Lymphödem und Belastung

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Miriam Groß
 Oberärztin des Brustzentrums
 Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
 Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie